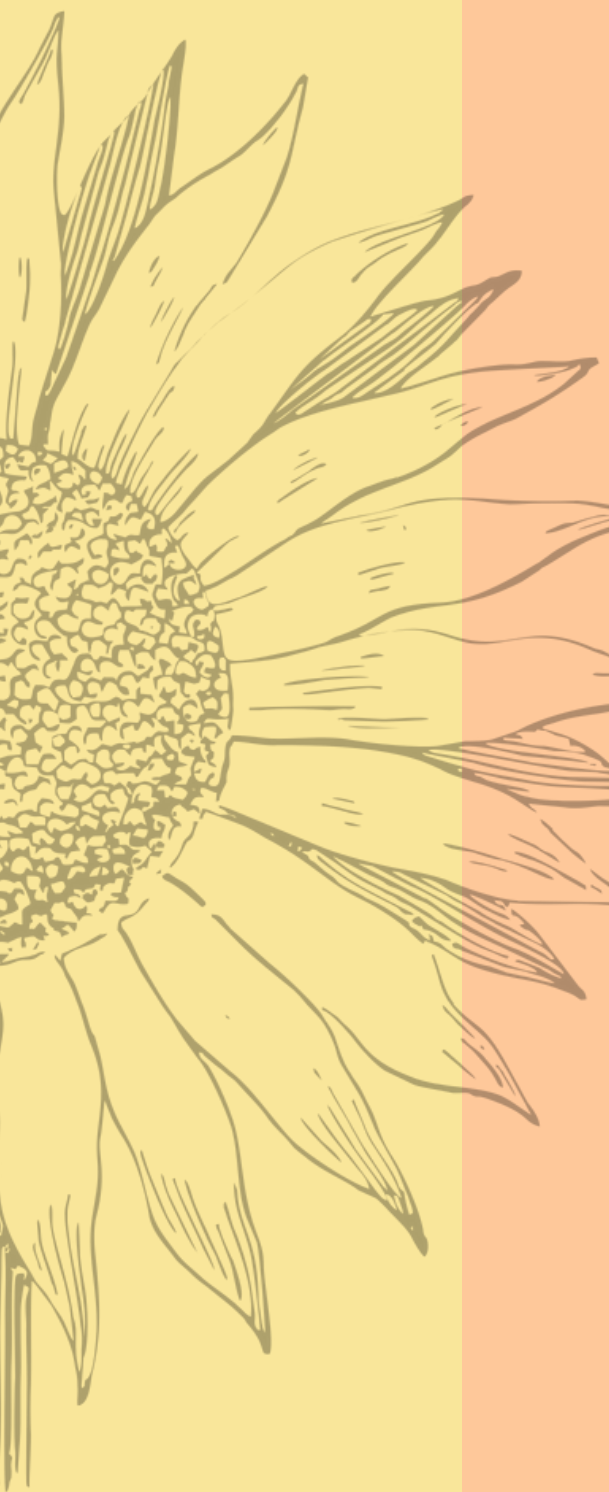




*Inclusão de crianças
com TEA, TDAH e TOD*



Infância sem rótulo

Cartilha Orientativa

COLABORADORES:

Ana Jullia Dias Oliveira

Apoenna Greicy Moreira Sousa

Hannah Victória Matos da Costa

Iavatha Gabrielly Teixeira de Araújo Miranda

Lara Júlia da Silva Oliveira

Luna Vitória Silva Alves

Maria Emilly Silva Sousa

María Gabrielly da Silva Carvalho

Maria Luiza Alencar e Silva

Victor Matheus Sales Moura Sousa

*Inclusão é
responsabilidade
de todos.*

SUMÁRIO

1. OQUE É TEA,TOD E TDAH

1.1. TEA

1.2. TOD

1.3. TDAH

2. DESCONSTRUINDO RÓTULOS

3. COMO CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DESSAS CRIANÇAS?

3.1 INCLUSÃO NO AMBIENTE ESCOLAR

3.2. INCLUSÃO NA FAMILIA

3.3. INCLUSÃO ENTRE AS CRIANÇAS

3.4 INCLUSÃO NA SOCIEDADE

4. COMO FAZER A DIFERENÇA?

5. REFERÊNCIAS

1. OQUE É TEA,TOD E TDAH:

1.1. TEA (Transtorno do Espectro Autista) :

É uma condição do desenvolvimento do cérebro que afeta a comunicação, a interação social e os comportamentos. O termo “espectro” indica que o autismo se manifesta de formas diferentes em cada pessoa, desde quadros leves até casos que exigem maior apoio no dia a dia.

1.2. TOD (Transtorno Desafiador Opositor)

É um transtorno disruptivo, caracterizado por um padrão global de desobediência, desafio e comportamento hostil, possuem dificuldade em aceitar regras e perdem facilmente o controle se as coisas não seguem a forma que eles desejam. Apesar de ser uma entidade diagnóstica independente, é frequentemente estudada em conjunto com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) ou com transtorno de conduta (TC).

1.3. TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade) :

É uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade e impulsividade que pode interferir no funcionamento acadêmico, profissional, social e familiar.

2. DESCONSTRUINDO RÓTULOS

O artigo “Interregulação, consciência e atenção compartilhadas: Despatologizando o TDAH”, de Jairo Werner Júnior e Thales Albuquerque Reynaud Schaefer, publicado em 2024 na *Revista Psicopedagogia*, apresenta uma análise crítica da forma como o TDAH é compreendido, principalmente no contexto escolar. Os autores utilizam uma perspectiva histórico-cultural, fundamentada principalmente nas contribuições de Vigotski, para discutir se comportamentos como desatenção, hiperatividade e impulsividade devem ser compreendidos exclusivamente como características individuais da criança. Segundo os autores, uma dificuldade importante está em analisar determinados comportamentos como se eles fossem produzidos somente dentro do indivíduo. Quando uma criança apresenta dificuldades de atenção, comportamento ou aprendizagem, existe o risco de a investigação se concentrar exclusivamente em descobrir “o que há de errado com ela”. A perspectiva apresentada pelo artigo propõe ampliar essa análise: é necessário observar as relações da criança com outras pessoas, as atividades realizadas, o ambiente escolar, as expectativas dos adultos e as condições em que determinado comportamento aparece. Assim, a dificuldade não deve ser automaticamente interpretada como uma característica fixa e isolada da criança.

No artigo, despatologizar não significa negar a existência do TDAH ou dizer que nenhuma criança precisa de diagnóstico ou tratamento. A crítica dos autores está principalmente na possibilidade de reduzir a compreensão da criança ao diagnóstico. Quando uma criança passa a ser conhecida principalmente pelo diagnóstico, familiares e profissionais podem começar, mesmo sem intenção, a interpretar diferentes comportamentos através desse rótulo. Por exemplo, uma dificuldade momentânea de concentração pode ser imediatamente associada ao TDAH, enquanto uma mudança de comportamento pode ser interpretada como consequência do transtorno.

O artigo chama atenção para o risco de isso produzir uma espécie de explicação circular: a criança apresenta determinado comportamento porque “tem TDAH”, e sabemos que ela “tem TDAH” porque apresenta aquele comportamento. Por isso, os autores defendem uma avaliação que procure compreender como os comportamentos se constituem nas relações e situações concretas.

Com base nas orientações do Ministério da Saúde, o atendimento à criança com TEA deve considerar suas características individuais, necessidades, potencialidades e contexto de vida, evitando que o diagnóstico seja utilizado para definir toda a sua identidade. Além disso, destaca a necessidade de enfrentar estigmas, preconceitos e barreiras que podem dificultar a participação da pessoa com TEA na sociedade.

Dessa forma, a criança não deve ser vista apenas pelo que apresenta como dificuldade, mas também por suas capacidades e pela forma como o ambiente pode oferecer os apoios necessários. O objetivo dessa proposta é mudar a visão de *“uma criança com autismo”* como alguém definido exclusivamente pelo diagnóstico para uma compreensão mais ampla: uma criança que possui características e necessidades específicas, mas que também tem personalidade, interesses, habilidades, relações e potencialidades próprias. Isso ajuda a evitar que o diagnóstico determine antecipadamente o que os adultos esperam dela.

O artigo “Entre um laudo e uma lei: um estudo de caso de transtorno opositor desafiador (TOD)”, de Gomes, Silva e Pires (2025), analisa a trajetória de um estudante com diagnóstico de TOD e mostra como a falta de preparo e de estratégias inclusivas pode fazer com que a criança ou adolescente seja reduzido ao seu comportamento ou ao seu diagnóstico. Os autores identificam situações em que estudantes com TOD são interpretados como “mal-educados” ou “indisciplinados”, o que pode contribuir para práticas punitivas e excludentes. A principal reflexão é que o diagnóstico deve servir para compreender necessidades e orientar formas de apoio, e não para definir quem a criança é. Em vez de enxergá-la apenas como “desafiadora”, “problemática” ou “indisciplinada”, é importante considerar sua história,

suas relações, suas dificuldades, suas capacidades e o contexto em que os comportamentos acontecem.

Como objetivo final devemos reconhecer que uma criança com TDAH, TEA ou TOD não se resumem ao transtorno. O diagnóstico pode ser relevante para identificar necessidades e organizar cuidados, mas não deve substituir a compreensão da criança como sujeito singular, inserido em relações familiares, sociais, culturais e educacionais.

3. COMO CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO DESSAS CRIANÇAS?

3.1. INCLUSÃO NA ESCOLA:

Incluir não significa simplesmente permitir que a criança esteja presente na sala de aula. Significa criar condições para que ela possa aprender, brincar, participar das atividades e estabelecer relações com os colegas. Além disso, situações de bullying, isolamento ou discriminação precisam ser reconhecidas e enfrentadas pela comunidade escolar.

A escola pode contribuir para a inclusão por meio de estratégias que considerem as necessidades individuais. Como por exemplo:

- Instruções claras e objetivas.
- Rotinas previsíveis.
- Recursos visuais.
- Adaptação de atividades quando necessário.

- Espaços com menos estímulos quando apropriado.
- Respeito ao tempo de cada criança.
- Mediação de conflitos.
- Combate ao bullying e à exclusão.

3.2. INCLUSÃO NA FAMÍLIA:

A família é um dos primeiros espaços de convivência e desenvolvimento da criança. Escutar suas necessidades, reconhecer suas emoções e estabelecer limites de maneira respeitosa são atitudes importantes. Também é fundamental evitar comparações com outras crianças e não utilizar o diagnóstico como forma de definir sua personalidade ou suas capacidades. Usufrindo de informações confiáveis e, quando necessário, orientação de profissionais especializados. O objetivo não é exigir que a criança se comporte como todas as outras, mas ajudá-la a desenvolver autonomia e encontrar estratégias que favoreçam sua participação e bem-estar.

3.3. INCLUSÃO ENTRE AS CRIANÇAS:

Em vez de incentivar a exclusão de uma criança por apresentar determinado comportamento, os adultos podem ajudar os colegas a compreender as diferenças e encontrar formas respeitosas de interação. Ensinar inclusão desde a infância contribui para construir relações baseadas na cooperação, no respeito e na valorização da diversidade.

3.4. INCLUSÃO NA SOCIEDADE:

Combater o preconceito significa questionar estereótipos, buscar informações em fontes confiáveis e evitar generalizações como “todo autista é igual” ou “criança com TDAH não consegue aprender”. Uma sociedade inclusiva não exige que todas as pessoas sejam iguais. Ela procura garantir que diferentes pessoas tenham oportunidades de participar, conviver e se desenvolver com dignidade e respeito.

4. COMO FAZER A DIFERENÇA:

- Dê espaço para a criança se expressar.
- Preste atenção às situações que geram dificuldades.
- Use uma linguagem clara e respeitosa.
- Reconheça emoções e necessidades.
- Quando necessário, modifique estratégias e ambientes.
- Valorize participação, autonomia e conquistas.

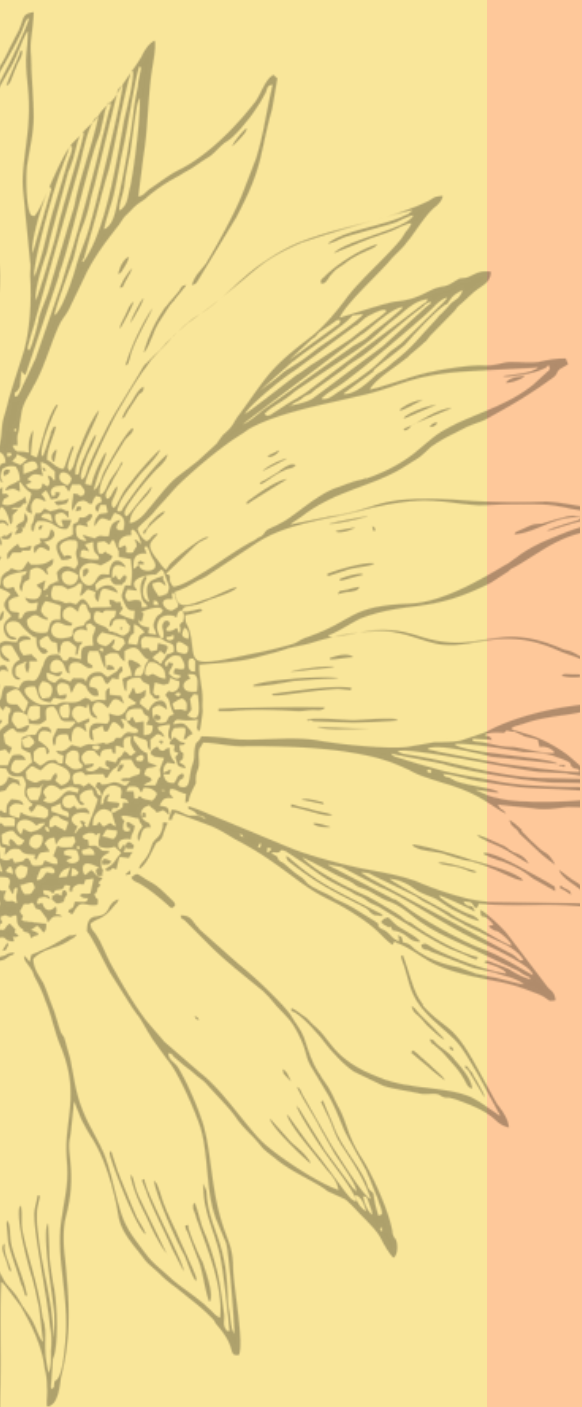
Pequena reflexão, o que você faria?

Durante uma atividade, uma criança começa a demonstrar irritação e não quer continuar. Seu primeiro pensamento talvez seja “ela está desinteressada”. Repense: O que pode estar acontecendo? Como posso ajudar sem julgar?

Dessa forma, podemos contribuir para a redução de rótulos em relação às crianças com TOD, TEA e TDAH visto no tópico 2 desta cartilha.

5. REFÊRENCIAS

- Brasil - Entre um laudo e uma lei: um estudo de caso de transtorno opositor desafiador (TOD) Entre um laudo e uma lei: um estudo de caso de transtorno opositor desafiador (TOD)
- <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/pts>
- [url=https%3A%2F%2Fpepsic.bvsalud.org%2Fscielo.php%3Fpid%3DS0103-84862024000100006%26script%3Dsci_arttext%26utm_](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/pts)
- [//www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/faq/o-que-e-o-transtorno?utm_](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/autismo/faq/o-que-e-o-transtorno?utm_)
- https://bvsms.saude.gov.br/transtorno-do-deficit-de-atencao-com-hiperatividade-tdah/?utm_
- Livro- Crianças desafiadoras por Luciana Brites e Dr. Clay Brites



ANTES DO DIAGNÓSTICO, EXISTE UMA CRIANÇA.